

PUNTO ENARM

Temas pendientes de nota en el vault

327 preguntas · 13/09/2026 · La Mole (Los 4 Fantásticos)

N349 (Tue Feb 17): CLASIFICACIÓN DE PLACENTA PREVIA: TOTAL, PARCIAL, MARGINAL Y DE INSERCIÓN BAJA

N350 (Tue Feb 17): FACTOR DE RIESGO MÁS IMPORTANTE PARA PLACENTA PREVIA: CESÁREA PREVIA

N352 (Wed Feb 18): EN PLACENTA PREVIA TOTAL LA VÍA DE RESOLUCIÓN ES CESÁREA

N354 (Wed Feb 18): ¿CUÁL ES EL ESTUDIO DE PRIMERA ELECCIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE ACALASIA? ESOFAGOGRAMA BARITADO (IMAGEN EN PICO DE PÁJARO, COLA DE RATÓN)

N355 (Wed Feb 18): ¿CUÁL ES EL GOLD STANDARD PARA EL DIAGNÓSTICO DE ACALASIA? MANOMETRÍA ESOFÁGICA CON FALTA DE RELAJACIÓN DEL ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR Y APERISTALSIS

N356 (Wed Feb 18): ¿EN QUÉ PACIENTES DEBE REALIZARSE DE FORMA OBLIGATORIA LA MANOMETRÍA ESOFÁGICA? EN TODOS LOS PACIENTES QUE SERÁN SOMETIDOS A CIRUGÍA

N357 (Wed Feb 18): ¿POR QUÉ SE DEBE REALIZAR UN ESOFAGOGRAMA ANUAL EN PACIENTES CON ACALASIA? POR EL RIESGO DE CARCINOMA EPIDERMÓIDE

N358 (Wed Feb 18): ¿CÓMO SE DEFINE LA ACALASIA? TRASTORNO DE LA MOTILIDAD ESOFÁGICA CARACTERIZADO POR DEFICIENTE RELAJACIÓN DEL ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR Y PÉRDIDA DE PERISTALSIS ESOFÁGICA

N359 (Wed Feb 18): ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL COMPLICACIÓN DE LA ACALASIA? MEGAESÓFAGO

N360 (Wed Feb 18): ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL DE ELECCIÓN PARA LA ACALASIA? MIOTOMÍA DE HELLER MÁS FUNDUPLICATION PARCIAL

N361 (Thu Feb 19): ¿CUÁL ES LA SEGUNDA ELECCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA ACALASIA? DILATACIÓN NEUMÁTICA CON BALÓN DE 30-40 MM

N362 (Thu Feb 19): ¿CUÁL ES EL ESTUDIO DE PRIMERA ELECCIÓN PARA ESPASMO ESOFÁGICO DIFUSO? SERIE ESOFAGOGASTRODUODENAL (IMAGEN EN SACACORCHOS)

N363 (Thu Feb 19): ¿CUÁL ES EL GOLD STANDARD PARA EL DIAGNÓSTICO DE ESPASMO ESOFÁGICO DIFUSO? MANOMETRÍA ESOFÁGICA

N364 (Thu Feb 19): ¿CUÁL ES EL GOLD STANDARD PARA EL DIAGNÓSTICO DE ERGE? PHMETRÍA CON IMPEDANCIA EN 24 HORAS

N365 (Thu Feb 19): ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ELECCIÓN PARA ERGE? FUNDUPLICATION DE NISSEN

N366 (Fri Feb 20): ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL COMPLICACIÓN DE LA ESOFAGITIS? ÚLCERA ESOFÁGICA

N367 (Fri Feb 20): ¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DEL ESÓFAGO DE BARRET? HISTOLÓGICO

N368 (Fri Feb 20): ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE ELECCIÓN EN ESÓFAGO DE BARRET? RESECCIÓN MUCOSA Y ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA

N369 (Fri Feb 20): ¿CUÁL ES EL ESTUDIO DE ELECCIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DEL DIVERTÍCULO DE ZENKER? ESOFAGOGRAMA BARITADO C5-C6

N371 (Fri Feb 20): ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL CAUSA DE OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO DELGADO? BRIDAS POSTERIORES A EVENTO QUIRÚRGICO

N373 (Fri Feb 20): EN OBSTRUCCIÓN DISTAL DE INTESTINO DELGADO, ¿CUÁL ES LA CARACTERÍSTICA DEL VÓMITO? FECALOIDE

N374 (Fri Feb 20): EN OBSTRUCCIÓN PROXIMAL DE INTESTINO DELGADO, ¿CUÁL ES LA CARACTERÍSTICA DEL VÓMITO? GASTROALIMENTARIO

N375 (Fri Feb 20): ¿CUÁL ES EL ESTUDIO INICIAL EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL? RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN AP EN BIPEDESTACIÓN

N376 (Mon Feb 23): ¿CUÁL ES EL GOLD STANDARD PARA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL? TAC

N378 (Mon Feb 23): ¿CUÁL ES LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO GRUESO? CÁNCER COLORRECTAL

N379 (Mon Feb 23): ¿CUÁL ES EL LUGAR DE PERFORACIÓN MÁS FRECUENTE EN OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO GRUESO? CIEGO

N380 (Mon Feb 23): ¿CUÁL ES EL VÓLVULO QUE CORRESPONDE AL 75% DE LOS CASOS? VÓLVULO DE SIGMOIDES

N381 (Tue Feb 24): ¿CUÁL ES EL HALLAZGO RADIOGRÁFICO MÁS SENSIBLE EN VÓLVULO DE SIGMOIDES? IMAGEN EN GRANO DE CAFÉ

N382 (Tue Feb 24): ¿CUÁL ES EL HALLAZGO RADIOGRÁFICO MÁS FRECUENTE EN VÓLVULO DE SIGMOIDES? AUSENCIA DE GAS RECTAL

N383 (Tue Feb 24): ¿CUÁL ES EL SIGNO EN ENEMA DE BARIO EN VÓLVULO DE SIGMOIDES? SIGNO DEL AS DE ESPADAS

N384 (Tue Feb 24): ¿QUÉ ES EL VÓLVULO DE CIEGO? TORSIÓN DEL CIEGO SOBRE EL EJE MESENTÉRICO

N399 (Thu Feb 26): LAS MANIOBRAS DE NEER Y HAWKINS POSITIVAS ORIENTAN A SINDROME DEL MANGUITO ROTADOR

N400 (Thu Feb 26): LOS MUSCULOS AFECTADOS EN EL SINDROME DEL MANGUITO ROTADOR SON SUPRAESPINOSO, INFRAESPINOSO, REDONDO MENOR Y SUBESCAPULAR

N401 (Thu Feb 26): EL TRATAMIENTO INICIAL DEL SINDROME DE HOMBRO DOLOROSO ES MANEJO FISIOTERAPEUTICO

N402 (Thu Feb 26): EN SINDROME DEL MANGUITO ROTADOR SE PUEDE UTILIZAR INFILTRACION INTRAARTICULAR CON CORTICOESTEROIDE MAS LIDOCAINA

N422 (Tue Mar 03): LA LUXACION DE CADERA MAS FRECUENTE ES LA POSTERIOR (90%)

N423 (Tue Mar 03): EN LA LUXACION POSTERIOR DE CADERA EL MIEMBRO ESTA ACORTADO, EN ROTACION INTERNA Y FLEXION

N424 (Tue Mar 03): LA LUXACION DE CADERA REQUIERE REDUCCION CERRADA URGENTE BAJO ANESTESIA

N430 (Tue Mar 03): EL GOLD ESTANDAR EN ARTRITIS SEPTICA ES EL CULTIVO DE LIQUIDO SINOVIAL

N431 (Wed Mar 04): LA ETIOLOGIA MAS FRECUENTE DE ARTRITIS SEPTICA ES STAPHYLOCOCCUS AUREUS

N432 (Wed Mar 04): LA VIA MAS FRECUENTE DE INFECCION EN ARTRITIS SEPTICA ES HEMATOGENA

N433 (Wed Mar 04): EL TRATAMIENTO INICIAL DE ARTRITIS SEPTICA ES INMOVILIZACION MAS ANTIBIOTICO POR 4?6 SEMANAS

N434 (Wed Mar 04): LA OSTEOMIELITIS ES UNA INFECCION DEL HUESO QUE AFECTA CAVIDAD MEDULAR, PERIOSTIO Y TEJIDO OSEO

N435 (Wed Mar 04): LA ETIOLOGIA MAS FRECUENTE DE OSTEOMIELITIS ES STAPHYLOCOCCUS AUREUS (80?90%)

N436 (Thu Mar 05): LOS PILARES DEL TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS SON DRENAJE QUIRURGICO, INMOVILIZACION Y ANTIBIOTICO INTRAVENOSO

N438 (Thu Mar 05): EL GOLD ESTANDAR DIAGNOSTICO EN NECROSIS AVASCULAR DE CABEZA FEMORAL ES RESONANCIA MAGNETICA

N443 (Thu Mar 05): EL HUESO DEL CARPO QUE MAS SE LUXA ES EL SEMILUNAR

N444 (Thu Mar 05): LA NEUROPATIA POR COMPRESION MAS FRECUENTE ES EL SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO

N445 (Thu Mar 05): EL TUMOR OSEO BENIGNO MAS FRECUENTE ES EL OSTEOCONDROMA

N453 (Mon Mar 09): LA TENDINITIS DEL SUPRAESPINOZO ES LA CAUSA MAS FRECUENTE DE HOMBRO DOLOROSO

N454 (Mon Mar 09): LA TENDINITIS CALCIFICANTE DEL HOMBRO SE CONFIRMA CON RADIOGRAFIA

N455 (Mon Mar 09): LA EPICONDILITIS SE CONOCE COMO CODO DE TENISTA

N456 (Tue Mar 10): LA EPITROCLEITIS SE CONOCE COMO CODO DE GOLFISTA

N457 (Tue Mar 10): LA TENOSINOVITIS DE QUERVAIN ES LA INFLAMACION DE LA VAINA DE LOS TENDONES ABDUCTOR LARGO Y EXTENSOR CORTO DEL PULGAR

N458 (Tue Mar 10): LA BURSITIS PRERROTULIANA SE CONOCE COMO RODILLA DE BEATA

N459 (Tue Mar 10): LA BURSITIS ANSERINA OCURRE EN LA INSERCIÓN DE LOS TENDONES SARTORIO, SEMITENDINOSO Y GRACIL

N460 (Tue Mar 10): EL DOLOR DE LA BURSITIS ANSERINA AUMENTA AL SUBIR Y BAJAR ESCALERAS

N461 (Tue Mar 10): LA OSTEOARTRITIS ES LA ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA MAS FRECUENTE

N462 (Tue Mar 10): LAS ARTICULACIONES MAS AFECTADAS EN OSTEOARTRITIS SON RODILLA, CADERA, MANOS Y COLUMNA

N463 (Tue Mar 10): EL DOLOR EN OSTEOARTRITIS EMPEORA CON LA ACTIVIDAD Y MEJORA CON EL REPOSO

N464 (Tue Mar 10): LOS NODULOS DE HEBERDEN AFECTAN LAS ARTICULACIONES INTERFALANGICAS DISTALES

N465 (Tue Mar 10): LOS NODULOS DE BOUCHARD AFECTAN LAS ARTICULACIONES INTERFALANGICAS PROXIMALES

N466 (Wed Mar 11): EL GOLD STANDARD PARA DIAGNOSTICO DE OSTEOARTRITIS ES RADIOGRAFIA SIMPLE

N467 (Wed Mar 11): EL TRATAMIENTO INICIAL DE OSTEOARTRITIS ES PERDIDA DE PESO, EJERCICIO Y ANALGESICOS

N468 (Wed Mar 11): EL FARMACO DE PRIMERA LINEA EN OSTEOARTRITIS ES PARACETAMOL

N469 (Wed Mar 11): LA ARTRITIS REUMATOIDE ES UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNE SISTEMICA

N470 (Wed Mar 11): LAS ARTICULACIONES MAS AFECTADAS EN ARTRITIS REUMATOIDE SON METACARPOFALANGICAS Y PROXIMALES

N471 (Thu Mar 12): EL FACTOR REUMATOIDE Y LOS ANTICUERPOS ANTI-CCP SON MARCADORES DE ARTRITIS REUMATOIDE

N472 (Thu Mar 12): EL FARMACO MODIFICADOR DE LA ENFERMEDAD DE PRIMERA LINEA EN ARTRITIS REUMATOIDE ES METOTREXATO

N473 (Thu Mar 12): LA GOTA ES UNA ARTRITIS POR DEPOSITO DE CRISTALES DE URATO MONOSODICO

N474 (Thu Mar 12): LA ARTICULACION MAS AFECTADA EN GOTA ES LA PRIMERA METATARSOFALANGICA (PODOGRA)

N475 (Thu Mar 12): EL GOLD STANDARD PARA DIAGNOSTICO DE GOTA ES LA IDENTIFICACION DE CRISTALES DE URATO EN LIQUIDO SINOVIAL

N476 (Fri Mar 13): EL TRATAMIENTO DEL ATAQUE AGUDO DE GOTA ES AINE O COLCHICINA

N477 (Fri Mar 13): EL TRATAMIENTO CRONICO DE GOTA ES ALOPURINOL O FEBUXOSTAT

N478 (Fri Mar 13): LA PSEUDOGOTA ES PRODUCIDA POR CRISTALES DE PIROFOSFATO DE CALCIO

N479 (Fri Mar 13): LA ARTICULACION MAS AFECTADA EN PSEUDOGOTA ES LA RODILLA

N480 (Fri Mar 13): LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE SE ASOCIA AL HLA-B27

N481 (Fri Mar 13): LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE AFECTA PRINCIPALMENTE ARTICULACIONES SACROILIACAS #ENAR

N482 (Fri Mar 13): EL DOLOR EN ESPONDILITIS ANQUILOSANTE ES INFLAMATORIO, MEJORA CON EJERCICIO Y EMPEORA CON REPOSO

N483 (Fri Mar 13): EL HALLAZGO RADIOLOGICO CARACTERISTICO DE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE ES COLUMNA EN CAÑA DE BAMBU

N484 (Fri Mar 13): EL TRATAMIENTO INICIAL DE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE SON AINES

N485 (Fri Mar 13): LA ARTRITIS REACTIVA SE ASOCIA A INFECCIONES POR CHLAMYDIA, SALMONELLA, SHIGELLA Y YERSINIA

N486 (Mon Mar 16): LA TRIADA CLASICA DE ARTRITIS REACTIVA ES ARTRITIS, URETRITIS Y CONJUNTIVITIS

N487 (Mon Mar 16): LA ARTRITIS PSORIASICA SE ASOCIA A LESIONES CUTANEAS DE PSORIASIS

N488 (Mon Mar 16): EL DACTILITIS O ?DEDOS EN SALCHICHA? ES CARACTERISTICO DE ARTRITIS PSORIASICA

N489 (Mon Mar 16): LA LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO ES UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNE MULTISISTEMICA

N490 (Mon Mar 16): EL ANTICUERPO MAS SENSIBLE PARA LUPUS ES EL ANA

N491 (Mon Mar 16): EL ANTICUERPO MAS ESPECIFICO PARA LUPUS ES EL ANTI-DNA DE DOBLE CADENA

N492 (Mon Mar 16): LA DISMINUCION DE COMPLEMENTO C3 Y C4 SUGIERE ACTIVIDAD DE LUPUS

N493 (Mon Mar 16): EL SINDROME ANTIFOSFOLIPIDO SE ASOCIA A TROMBOSIS Y PERDIDAS GESTACIONALES

N494 (Mon Mar 16): LOS ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINA Y ANTICOAGULANTE LUPICO SON CARACTERISTICOS DE SINDROME ANTIFOSFOLIPIDO

N495 (Mon Mar 16): LA ESCLERODERMIA SE CARACTERIZA POR FIBROSIS CUTANEA Y DE ORGANOS INTERNOS

N496 (Tue Mar 17): EL FENOMENO DE RAYNAUD ES UNA MANIFESTACION TEMPRANA DE ESCLERODERMIA

N497 (Tue Mar 17): EL ANTICUERPO ANTICENTROMERO SE ASOCIA A ESCLERODERMIA LIMITADA

N498 (Tue Mar 17): EL ANTICUERPO ANTI-SCL70 SE ASOCIA A ESCLERODERMIA DIFUSA

N499 (Tue Mar 17): LA POLIMIOSITIS Y DERMATOMIOSITIS SON MIOPATIAS INFLAMATORIAS

N500 (Tue Mar 17): LA DEBILIDAD MUSCULAR PROXIMAL SIMETRICA ES CARACTERISTICA DE POLIMIOSITIS

N506 (Wed Mar 18): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE DIARREA ASOCIADA A ANTIBIOTICOS ES CLOSTRIDIODES DIFFICILE

N510 (Wed Mar 18): EL ESTUDIO DE ELECCION EN ADULTOS PARA APENDICITIS ES TAC ABDOMINAL

N511 (Thu Mar 19): EL TRATAMIENTO DEFINITIVO DE APENDICITIS ES APENDICECTOMIA

N515 (Thu Mar 19): EL TRATAMIENTO DEFINITIVO DE COLECISTITIS ES COLECISTECTOMIA

N519 (Thu Mar 19): LA HEMORRAGIA DE TUBO DIGESTIVO ALTO SE MANIFIESTA COMO HEMATEMESIS O MELENA

N520 (Thu Mar 19): LA PRINCIPAL CAUSA DE HEMORRAGIA DE TUBO DIGESTIVO ALTO SON LAS ULCERAS PEPTICAS

N521 (Thu Mar 19): LA SEGUNDA CAUSA DE HEMORRAGIA DE TUBO DIGESTIVO ALTO SON LAS VARICES ESOFAGICAS

N522 (Thu Mar 19): EL TRATAMIENTO INICIAL DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA ES ABC, LIQUIDOS Y TRANSFUSION SEGUN NECESIDAD

N523 (Thu Mar 19): EN HEMORRAGIA POR VARICES SE UTILIZA OCTREOTIDE

N524 (Thu Mar 19): EL TRATAMIENTO DEFINITIVO DE VARICES ESOFAGICAS ES LIGADURA ENDOSCOPICA

N529 (Fri Mar 20): EL TRATAMIENTO DE ASCITIS ES RESTRICCION DE SODIO Y DIURETICOS (ESPIRONOLACTONA)

N536 (Mon Mar 23): EL CHOQUE HIPOVOLEMICO SE CARACTERIZA POR DISMINUCION DEL GASTO CARDIACO Y AUMENTO DE RESISTENCIA VASCULAR

N538 (Mon Mar 23): EL MANEJO INICIAL DE CHOQUE ES ABC Y REPOSICION DE LIQUIDOS

N540 (Mon Mar 23): LA SEPSIS SE DEFINE COMO DISFUNCION ORGANICA SECUNDARIA A RESPUESTA DESREGULADA A INFECCION

N544 (Wed Mar 25): LA NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD ES CAUSADA PRINCIPALMENTE POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

N545 (Wed Mar 25): EL ESTUDIO DE ELECCION PARA NEUMONIA ES RADIOGRAFIA DE TORAX

N546 (Thu Mar 26): EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NEUMONIA ES AMOXICILINA O MACROLIDO

N547 (Thu Mar 26): LA ESCALA CURB-65 SE UTILIZA PARA EVALUAR GRAVEDAD DE NEUMONIA

N557 (Fri Mar 27): LA TUBERCULOSIS PULMONAR SE MANIFIESTA CON TOS CRONICA, FIEBRE Y SUDORACION NOCTURNA

N558 (Fri Mar 27): EL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS SE CONFIRMA CON BACILOSCOPIA O GENEXPERT

N559 (Fri Mar 27): EL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS ES ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA Y ETAMBUTOL

N560 (Fri Mar 27): LA FASE INTENSIVA DE TUBERCULOSIS DURA 2 MESES

N566 (Fri Mar 27): EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA PARA PCP ES TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL

N575 (Mon Mar 30): LA INFECCION URINARIA MAS FRECUENTE ES POR ESCHERICHIA COLI

N576 (Tue Mar 31): EL DIAGNOSTICO DE IVU SE REALIZA CON EXAMEN GENERAL DE ORINA Y UROCULTIVO

N579 (Tue Mar 31): EL TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS ES ANTIBIOTICO SISTEMICO

N580 (Tue Mar 31): LA BACTERIURIA ASINTOMATICA SOLO SE TRATA EN EMBARAZO Y PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS

N586 (Wed Apr 01): SI FC <60 LPM SE INICIAN COMPRESIONES TORACICAS

N587 (Wed Apr 01): LA RELACION COMPRESION:VENTILACION EN RN ES 3:1

N594 (Mon Apr 06): LA EXANGUINOTRANSFUSION SE INDICA EN CASOS GRAVES

N602 (Tue Apr 07): SE CONSIDERA BAJO PESO AL NACER <2500 GRAMOS

N603 (Tue Apr 07): SE CONSIDERA MACROSOMIA >4000 GRAMOS

N607 (Wed Apr 08): LA FRECUENCIA RESPIRATORIA NORMAL EN RN ES 30-60 RPM

N609 (Wed Apr 08): EL REFLEJO DE SUCCION ESTA PRESENTE DESDE EL NACIMIENTO

N621 (Thu Apr 09): LA INFECCION RESPIRATORIA AGUDA ES LA PRINCIPAL CAUSA DE MORBILIDAD EN NIÑOS

N622 (Thu Apr 09): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE RESFRIADO COMUN ES EL RINOVIRUS

N639 (Mon Apr 13): LA CRISIS FEBRIL ES LA CONVULSION MAS FRECUENTE EN NIÑOS

N640 (Mon Apr 13): LAS CRISIS FEBRILES SIMPLES SON GENERALIZADAS Y DURAN <15 MINUTOS

N642 (Mon Apr 13): EL SIGNO CLINICO MAS IMPORTANTE PARA EVALUAR DESHIDRATACION ES EL ESTADO GENERAL

N644 (Mon Apr 13): LA DESHIDRATACION MODERADA CORRESPONDE A PERDIDA DE 5?10% DEL PESO

N652 (Wed Apr 15): LA HIPONATREMIA SE DEFINE COMO NA <135 MEQ/L

N653 (Wed Apr 15): LA HIPERNATREMIA SE DEFINE COMO NA >145 MEQ/L

N654 (Wed Apr 15): LA HIPOCALEMIA SE DEFINE COMO K <3.5 MEQ/L

N655 (Wed Apr 15): LA HIPERCALEMIA SE DEFINE COMO K >5.5 MEQ/L

N656 (Thu Apr 16): EL SIGNO MAS GRAVE DE HIPERCALEMIA ES ARRITMIA CARDIACA

N657 (Thu Apr 16): EL CALCIO GLUCONATO SE USA PARA ESTABILIZAR MEMBRANA EN HIPERCALEMIA

N658 (Thu Apr 16): LA INSULINA CON GLUCOSA DISMINUYE EL POTASIO SERICO

N659 (Thu Apr 16): EL SALBUTAMOL TAMBIEN DISMINUYE EL POTASIO SERICO

N660 (Thu Apr 16): LA RESINA DE INTERCAMBIO (KAYEXALATE) ELIMINA POTASIO

N661 (Thu Apr 16): EL CHOQUE EN PEDIATRIA SE CLASIFICA EN HIPOVOLEMICO, DISTRIBUTIVO, CARDIOGENICO Y OBSTRUCTIVO

N662 (Thu Apr 16): EL CHOQUE HIPOVOLEMICO ES EL MAS FRECUENTE EN NIÑOS

N663 (Thu Apr 16): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE CHOQUE HIPOVOLEMICO EN PEDIATRIA ES DESHIDRATACION

N664 (Thu Apr 16): EL MANEJO INICIAL DEL CHOQUE ES ABC Y ADMINISTRACION DE LIQUIDOS

N668 (Fri Apr 17): LA ANAFILAXIA ES UNA REACCION DE HIPERSENSIBILIDAD GRAVE MEDIADA POR IGE

N669 (Fri Apr 17): EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA EN ANAFILAXIA ES ADRENALINA IM

N670 (Fri Apr 17): LA DOSIS DE ADRENALINA EN ANAFILAXIA ES 0.01 MG/KG IM

N672 (Mon Apr 20): LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE EN TRAUMA ES LA HEMORRAGIA

N673 (Mon Apr 20): EL NEUMOTORAX A TENSION ES UNA URGENCIA QUE REQUIERE DESCOMPRESION INMEDIATA

N674 (Mon Apr 20): EL TAPONAMIENTO CARDIACO SE MANIFIESTA CON LA TRIADA DE BECK

N678 (Mon Apr 20): EL SIGNO MAS IMPORTANTE PARA VALORAR ADECUADA REANIMACION ES LA DIURESIS

N679 (Mon Apr 20): LA DIURESIS META EN NIÑOS ES >1 ML/KG/HORA

N680 (Mon Apr 20): LAS QUEMADURAS DE TERCER GRADO REQUIEREN MANEJO QUIRURGICO

N684 (Tue Apr 21): EL ANTÍDOTO DE TOXICIDAD POR MAGNESIO ES GLUCONATO DE CALCIO

N692 (Thu Apr 23): EL TACTO VAGINAL ESTÁ CONTRAINDICADO EN SOSPECHA DE PLACENTA PREVIA

N701 (Mon Apr 27): EL SINDROME CORONARIO AGUDO SE CLASIFICA EN IAM CON ELEVACION DEL ST, SIN ELEVACION DEL ST Y ANGINA INESTABLE

N704 (Mon Apr 27): EL TRATAMIENTO INICIAL DEL SCA INCLUYE MONA: MORFINA, OXIGENO, NITRATOS Y ASPIRINA

N709 (Tue Apr 28): LA INSUFICIENCIA CARDIACA SE DEFINE COMO INCAPACIDAD DEL CORAZON PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DEL ORGANISMO

N710 (Tue Apr 28): EL SINTOMA MAS FRECUENTE DE INSUFICIENCIA CARDIACA ES DISNEA

N711 (Wed Apr 29): EL TRATAMIENTO DE BASE EN IC INCLUYE IECA, BETABLOQUEADOR Y DIURETICO

N712 (Wed Apr 29): EL PEPTIDO BNP SE ELEVA EN INSUFICIENCIA CARDIACA

N713 (Wed Apr 29): LA FIBRILACION AURICULAR ES LA ARRITMIA MAS FRECUENTE

N714 (Wed Apr 29): EL RIESGO DE FA ES EVENTO EMBOLICO CEREBRAL

N715 (Wed Apr 29): EL MANEJO DE FA INCLUYE CONTROL DE FRECUENCIA Y ANTICOAGULACION

N716 (Wed Apr 29): EL CHADSVASC SE UTILIZA PARA EVALUAR RIESGO DE EVC EN FA

N717 (Wed Apr 29): LA TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR SE MANEJA INICIALMENTE CON MANIOBRAS VAGALES

N718 (Wed Apr 29): LA ADENOSINA ES FARMACO DE ELECCION EN TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR

N719 (Wed Apr 29): LA BRADICARDIA SINTOMATICA SE MANEJA CON ATROPINA

N720 (Wed Apr 29): EL BLOQUEO AV COMPLETO REQUIERE MARCAPASOS

N723 (Thu Apr 30): LOS SINTOMAS CLASICOS DE DIABETES SON POLIURIA, POLIDIPSIA Y POLIFAGIA

N724 (Thu Apr 30): LA CETOACIDOSIS DIABETICA SE CARACTERIZA POR HIPERGLUCEMIA, ACIDOSIS METABOLICA Y CETONEMIA

N725 (Thu Apr 30): EL TRATAMIENTO DE CETOACIDOSIS INCLUYE LIQUIDOS, INSULINA Y CORRECCION DE ELECTROLITOS

N726 (Mon May 04): LA PRINCIPAL COMPLICACION DEL TRATAMIENTO DE CETOACIDOSIS ES HIPOCALEMIA

N727 (Mon May 04): EL ESTADO HIPEROSMOLAR SE CARACTERIZA POR HIPERGLUCEMIA SEVERA SIN CETOSIS SIGNIFICATIVA

N728 (Mon May 04): LA HIPOGLUCEMIA SE DEFINE COMO GLUCOSA <70 MG/DL

N729 (Mon May 04): EL TRATAMIENTO DE HIPOGLUCEMIA ES GLUCOSA ORAL O IV SEGUN GRAVEDAD

N738 (Tue May 05): EL HIPERPARATIROIDISMO CAUSA HIPERCALCEMIA

N739 (Tue May 05): EL HIPOPARATIROIDISMO CAUSA HIPOCALCEMIA

N740 (Tue May 05): LA HIPERCALCEMIA SE MANIFIESTA CON ?STONES, BONES, GROANS AND PSYCHIATRIC OVERSTONES?

N748 (Thu May 07): LA CRISIS EPILEPTICA GENERALIZADA TONICO-CLONICA ES LA MAS FRECUENTE

N749 (Thu May 07): EL STATUS EPILEPTICO ES UNA EMERGENCIA NEUROLOGICA

N750 (Thu May 07): EL TRATAMIENTO INICIAL DEL STATUS EPILEPTICO ES DIAZEPAM O LORAZEPAM

N751 (Fri May 08): LA MENINGITIS BACTERIANA SE MANIFIESTA CON FIEBRE, RIGIDEZ DE NUCA Y ALTERACION DEL ESTADO MENTAL

N752 (Fri May 08): LA TRIADA DE MENINGITIS ES FIEBRE, RIGIDEZ DE NUCA Y ALTERACION DEL ESTADO MENTAL

N753 (Fri May 08): EL ESTUDIO DIAGNOSTICO DE MENINGITIS ES PUNCION LUMBAR

N754 (Fri May 08): EL TRATAMIENTO EMPIRICO DE MENINGITIS ES ANTIBIOTICOS DE AMPLIO ESPECTRO

N755 (Fri May 08): LA ENCEFALITIS MAS FRECUENTE ES POR VIRUS HERPES SIMPLE

N756 (Mon May 11): EL TRATAMIENTO DE ENCEFALITIS HERPETICA ES ACICLOVIR

N757 (Mon May 11): LA MIGRAÑA ES UNA CEFALEA PULSATIL UNILATERAL CON NAUSEA Y FOTOFONOFIA

N758 (Mon May 11): EL TRATAMIENTO AGUDO DE MIGRAÑA ES AINES O TRIPTANOS

N759 (Mon May 11): LA CEFALEA EN RACIMOS SE CARACTERIZA POR DOLOR INTENSO PERIORBITARIO

N760 (Mon May 11): EL TRATAMIENTO DE CEFALEA EN RACIMOS ES OXIGENO Y SUMATRIPTAN

N761 (Tue May 12): LA LESION RENAL AGUDA SE DEFINE POR AUMENTO DE CREATININA O DISMINUCION DE DIURESIS

N762 (Tue May 12): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE LESION RENAL AGUDA ES PRERRENAL

N763 (Tue May 12): LA NECROSIS TUBULAR AGUDA ES LA CAUSA MAS FRECUENTE DE IRA INTRINSECA

N764 (Tue May 12): LA HIPERKALEMIA ES LA ALTERACION ELECTROLITICA MAS GRAVE EN IRA

N766 (Wed May 13): AEIOU SIGNIFICA ACIDOSIS, ELECTROLITOS, INTOXICACIONES, OVERLOAD Y UREMIA

N771 (Thu May 14): EL SINDROME NEFROTICO SE CARACTERIZA POR PROTEINURIA >3.5 G/DIA, HIPOALBUMINEMIA Y EDEMA

N772 (Thu May 14): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE SINDROME NEFROTICO EN NIÑOS ES CAMBIOS MINIMOS

N773 (Thu May 14): EL SINDROME NEFRITICO SE CARACTERIZA POR HEMATURIA, HTA Y EDEMA

N774 (Thu May 14): LA GLOMERULONEFRITIS POSTESTREPTOCOCICA OCURRE DESPUES DE INFECCION FARINGEA O CUTANEA

N775 (Thu May 14): EL COMPLEMENTO C3 DISMINUIDO ES CARACTERISTICO DE GLOMERULONEFRITIS POSTESTREPTOCOCICA

N776 (Fri May 15): LA PIELONEFRITIS AGUDA SE MANIFIESTA CON FIEBRE, DOLOR EN ANGULO COSTOVERTEBRAL Y PIURIA

N791 (Fri May 22): LA LEUCEMIA AGUDA MAS FRECUENTE EN NIÑOS ES LA LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA

N792 (Fri May 22): LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA ES MAS FRECUENTE EN ADULTOS

N793 (Fri May 22): LOS BASTONES DE AUER SON CARACTERISTICOS DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

N794 (Fri May 22): LA TRANSLOCACION T(15;17) SE ASOCIA A LEUCEMIA PROMIELOCITICA AGUDA

N795 (Fri May 22): EL TRATAMIENTO DE LEUCEMIA PROMIELOCITICA INCLUYE ATRA

N796 (Fri May 22): EL LINFOMA DE HODGKIN SE CARACTERIZA POR CELULAS DE REED-STERBERG

N797 (Fri May 22): EL GANGLIO CERVICAL ES EL SITIO MAS FRECUENTE EN LINFOMA DE HODGKIN

N798 (Fri May 22): LOS SINTOMAS B SON FIEBRE, SUDORACION NOCTURNA Y PERDIDA DE PESO

N799 (Fri May 22): LA NEUTROPENIA FEBRIL ES UNA URGENCIA ONCOLOGICA

N800 (Fri May 22): EL TRATAMIENTO INICIAL DE NEUTROPENIA FEBRIL ES ANTIBIOTICO DE AMPLIO ESPECTRO

N840 (Tue Jun 02): EL LEIOMIOSARCOMA ES UNA NEOPLASIA MALIGNA DEL MUSCULO LISO UTERINO

N841 (Wed Jun 03): EL SÍNDROME DE MALLORY-WEISS CONSISTE EN DESGARROS LONGITUDINALES EN ESÓFAGO DISTAL Y ESTÓMAGO PROXIMAL SECUNDARIOS A AUMENTO DE LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL

N842 (Wed Jun 03): LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE SÍNDROME DE MALLORY-WEISS EN HOMBRES ES EL ALCOHOLISMO

N843 (Wed Jun 03): LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE SÍNDROME DE MALLORY-WEISS EN MUJERES ES LA HIPERÉMESIS GRAVÍDICA

N844 (Wed Jun 03): LA ENDOSCOPIA EN MALLORY-WEISS SE RECOMIENDA ENTRE LAS 6 Y 24 HORAS POSTERIORES AL EVENTO

N845 (Wed Jun 03): EL TRATAMIENTO INICIAL DEL SÍNDROME DE MALLORY-WEISS ES ABCDE Y ESTABILIZACIÓN HEMODINÁMICA

N846 (Thu Jun 04): LA PROTEÍNA PATÓGENA MÁS IMPORTANTE DE HELICOBACTER PYLORI ES CAGA

N847 (Thu Jun 04): EL ESTUDIO INICIAL DE ELECCIÓN PARA HELICOBACTER PYLORI ES LA PRUEBA DE ALIENTO CON UREA MARCADA CON CARBONO 13

N848 (Thu Jun 04): LAS COMPLICACIONES CLÁSICAS DE HELICOBACTER PYLORI SON GASTRITIS CRÓNICA TIPO B, ÚLCERA PÉPTICA, LINFOMA MALT Y ADENOCARCINOMA GÁSTRICO

N849 (Thu Jun 04): EL TRATAMIENTO TRIPLE CLÁSICO PARA ERRADICACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI ES AMOXICILINA MÁS CLARITROMICINA MÁS IBP DURANTE 14 DÍAS

N850 (Thu Jun 04): PARA SER CONSIDERADA ÚLCERA PÉPTICA DEBE PENETRAR MÁS ALLÁ DE LA MUSCULAR DE LA MUCOSA

N851 (Fri Jun 05): LA PRINCIPAL CAUSA DE ÚLCERA PÉPTICA ES HELICOBACTER PYLORI

N852 (Fri Jun 05): LA PRINCIPAL CAUSA DE SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO ALTO ES EL CONSUMO CRÓNICO DE AINES

N853 (Fri Jun 05): LA PRINCIPAL CAUSA DE REFRACTARIEDAD DE UNA ÚLCERA PÉPTICA ES EL TABAQUISMO

N854 (Fri Jun 05): LOS INHIBIDORES DE BOMBA DE PROTONES DEBEN ADMINISTRARSE 30 MINUTOS ANTES DE LOS ALIMENTOS

N855 (Fri Jun 05): LA LOCALIZACIÓN MÁS FRECUENTE DE LA ÚLCERA GÁSTRICA ES LA CURVATURA MENOR

N856 (Mon Jun 08): LAS ÚLCERAS GÁSTRICAS CON MAYOR FRECUENCIA DE SANGRADO SON LAS PREPILÓRICAS

N857 (Mon Jun 08): LA ÚLCERA DUODENAL SUELE LOCALIZARSE EN LA PRIMERA PORCIÓN DEL DUODENO

N858 (Mon Jun 08): EL DOLOR DE LA ÚLCERA DUODENAL APARECE DOS HORAS DESPUÉS DE COMER Y MEJORA CON ALIMENTOS O ANTÍACIDOS

N859 (Mon Jun 08): LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE EN LA ÚLCERA PÉPTICA COMPLICADA ES EL SANGRADO

N860 (Mon Jun 08): LA ESCALA DE ROCKALL PREDICE MORTALIDAD Y NECESIDAD DE HOSPITALIZACIÓN EN SANGRADO POR ÚLCERA PÉPTICA

N861 (Mon Jun 08): LA ESCALA DE BLATCHFORD AYUDA A DECIDIR INTERVENCIÓN ENDOSCÓPICA TEMPRANA

N862 (Mon Jun 08): EL SIGNO RADIOLÓGICO CLÁSICO DE UNA ÚLCERA PERFORADA ES AIRE SUBDIAFRAGMÁTICO

N863 (Mon Jun 08): EL ESTUDIO INICIAL EN ÚLCERA PERFORADA ES LA RADIOGRAFÍA TORACOABDOMINAL

N864 (Mon Jun 08): LA ENFERMEDAD DE MENÉTRIER SE DEBE A SOBREEXPRESIÓN DE TGF-ALFA CON HIPERPLASIA FOVEOLAR

N865 (Mon Jun 08): EL ESTUDIO DE ELECCIÓN PARA ENFERMEDAD DE MENÉTRIER ES ENDOSCOPIA CON BIOPSIA

N866 (Tue Jun 09): EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE MENÉTRIER ES CETUXIMAB; EN CASOS REFRACTARIOS SE REALIZA GASTRECTOMÍA TOTAL

N867 (Tue Jun 09): EL 90% DE LOS GASTRINOMAS SE LOCALIZAN EN EL TRIÁNGULO DE PASSARO

N868 (Tue Jun 09): EL ESTUDIO INICIAL PARA SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON ES GASTRINA SÉRICA EN AYUNO MÁS MEDICIÓN DE PH GÁSTRICO

N869 (Tue Jun 09): EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ZOLLINGER-ELLISON ES OMEPRAZOL EN DOSIS ALTAS

N870 (Tue Jun 09): EL SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON SE ASOCIA A NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 1

N871 (Wed Jun 10): LA PRUEBA CONFIRMATORIA PARA SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON ES LA PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON SECRETINA

N872 (Wed Jun 10): LA TRIADA CLÁSICA DE LA ACALASIA ES DISFAGIA, REGURGITACIÓN Y PÉRDIDA DE PESO

N873 (Wed Jun 10): EL ESTÁNDAR DE ORO PARA DIAGNÓSTICO DE ACALASIA ES LA MANOMETRÍA ESOFÁGICA

N874 (Wed Jun 10): EL SIGNO RADIOLÓGICO CARACTERÍSTICO DE ACALASIA ES EL ESÓFAGO EN PICO DE PÁJARO

N875 (Wed Jun 10): EL TRATAMIENTO DEFINITIVO DE LA ACALASIA ES LA MIOTOMÍA DE HELLER CON FUNDUPLICATURA

N876 (Wed Jun 10): EL ESÓFAGO DE BARRETT ES LA METAPLASIA DEL EPITELIO ESCAMOSO ESOFÁGICO A EPITELIO COLUMNAR INTESTINAL

N877 (Wed Jun 10): EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO PARA ESÓFAGO DE BARRETT ES LA ERGE CRÓNICA

N878 (Wed Jun 10): EL ESÓFAGO DE BARRETT AUMENTA EL RIESGO DE ADENOCARCINOMA ESOFÁGICO

N879 (Wed Jun 10): EL ESTUDIO DE ELECCIÓN PARA DIAGNÓSTICO DE ESÓFAGO DE BARRETT ES ENDOSCOPIA CON BIOPSIA

N880 (Wed Jun 10): EL TRATAMIENTO INICIAL DE LA ERGE CONSISTE EN MODIFICACIONES DEL ESTILO DE VIDA E IBP

N881 (Fri Jun 12): LA PRUEBA CONFIRMATORIA PARA SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON ES LA PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON SECRETINA

N882 (Fri Jun 12): LA TRÍADA CLÁSICA DE LA ACALASIA ES DISFAGIA, REGURGITACIÓN Y PÉRDIDA DE PESO

N883 (Fri Jun 12): EL ESTÁNDAR DE ORO PARA EL DIAGNÓSTICO DE ACALASIA ES LA MANOMETRÍA ESOFÁGICA

N884 (Fri Jun 12): EL SIGNO RADIOLÓGICO CARACTERÍSTICO DE LA ACALASIA ES EL ESÓFAGO EN PICO DE PÁJARO

N885 (Fri Jun 12): EL TRATAMIENTO DEFINITIVO DE LA ACALASIA ES LA MIOTOMÍA DE HELLER CON FUNDUPLICATURA

N886 (Mon Jun 15): EL ESÓFAGO DE BARRETT ES LA METAPLASIA DEL EPITELIO ESCAMOSO ESOFÁGICO A EPITELIO COLUMNAR INTESTINAL

N887 (Mon Jun 15): EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO PARA ESÓFAGO DE BARRETT ES LA ERGE CRÓNICA

N888 (Mon Jun 15): EL ESÓFAGO DE BARRETT AUMENTA EL RIESGO DE ADENOCARCINOMA ESOFÁGICO

N889 (Mon Jun 15): EL ESTUDIO DE ELECCIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE ESÓFAGO DE BARRETT ES LA ENDOSCOPIA CON BIOPSIA

N890 (Mon Jun 15): EL TRATAMIENTO INICIAL DE LA ERGE CONSISTE EN MODIFICACIONES DEL ESTILO DE VIDA E IBP

N899 (Thu Jun 18): LA DISENTERÍA SE CARACTERIZA POR DIARREA CON SANGRE Y MOCO

N910 (Mon Jun 22): LA HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE DEL RECIÉN NACIDO SE DEBE A FALLA EN LA DISMINUCIÓN DE LA RESISTENCIA VASCULAR PULMONAR

N911 (Tue Jun 23): EL ESTÁNDAR DE ORO PARA EL DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE ES EL ECOCARDIOGRAMA

N912 (Tue Jun 23): EL ÓXIDO NÍTRICO INHALADO ES UN TRATAMIENTO IMPORTANTE EN HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE DEL RECIÉN NACIDO

N918 (Thu Jun 25): LA PROFILAXIS INTRAPARTO CON PENICILINA DISMINUYE EL RIESGO DE INFECCIÓN POR ESTREPTOCOCO DEL GRUPO B

N933 (Tue Jun 30): LA PROFILAXIS MÁS IMPORTANTE DE RUBÉOLA CONGÉNITA ES LA VACUNACIÓN MATERNA PREVIA AL EMBARAZO

N938 (Wed Jul 01): LA PROFILAXIS OCULAR NEONATAL DISMINUYE EL RIESGO DE OFTALMÍA NEONATORUM

N940 (Wed Jul 01): LA NEUMONÍA POR CHLAMYDIA EN EL LACTANTE CURSA CLÁSICAMENTE SIN FIEBRE Y CON EOSINOFILIA

N964 (Wed Jul 08): LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN TIENEN MAYOR RIESGO DE COLELITIASIS

N970 (Thu Jul 09): EN PACIENTES CON SIDA PUEDEN PRESENTARSE CASOS DE COLANGITIS POR CITOMEGALOVIRUS O CRIPTOSPORIDIOS

N971 (Fri Jul 10): LA ARTERIA CÍSTICA ES LA PRINCIPAL FUENTE DE IRRIGACIÓN DE LA VESÍCULA BILIAR

N986 (Wed Jul 15): EL PATRÓN COLESTÁSICO SE CARACTERIZA POR HIPERBILIRRUBINEMIA DIRECTA, ICTERICIA Y COLURIA

N996 (Fri Jul 17): LOS ANTICUERPOS ANTIMITOCONDRIALES POSITIVOS SON CARACTERÍSTICOS DE LA COLANGITIS BILIAR PRIMARIA

N997 (Fri Jul 17): LA BIOPSIA HEPÁTICA ES EL ESTÁNDAR DE ORO PARA EL DIAGNÓSTICO DE COLANGITIS BILIAR PRIMARIA

N1010 (Tue Jul 21): LAS RETRACCIONES INTERCOSTALES SON DATOS DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NEONATAL

N1019 (Fri Jul 24): LA HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE DEL RECIÉN NACIDO SE DIAGNOSTICA MEDIANTE ECOCARDIOGRAMA

N1020 (Fri Jul 24): EL ÓXIDO NÍTRICO INHALADO ES UNO DE LOS PRINCIPALES TRATAMIENTOS DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE DEL RECIÉN NACIDO

N1022 (Fri Jul 24): EL SIGNO DE CULLEN CONSISTE EN EQUIMOSIS PERIUMBILICAL

N1023 (Fri Jul 24): EL SIGNO DE GRAY-TURNER CONSISTE EN EQUIMOSIS EN LOS FLANCOS

N1032 (Tue Jul 28): UN PUNTAJE DE RANSON MAYOR DE 3 ES UN CRITERIO DE MAL PRONÓSTICO EN PANCREATITIS AGUDA

N1033 (Tue Jul 28): LA TOMOGRAFÍA ABDOMINAL CON CONTRASTE ES EL ESTÁNDAR DE ORO DE IMAGEN EN PANCREATITIS AGUDA

N1042 (Thu Jul 30): EL DOLOR CARACTERÍSTICO DE LA PANCREATITIS AGUDA ES EPIGÁSTRICO, INTENSO Y CON IRRADIACIÓN HACIA LA ESPALDA

N1043 (Thu Jul 30): UNA LIPASA O AMILASA MAYOR DE TRES VECES EL LÍMITE SUPERIOR NORMAL APOYA EL DIAGNÓSTICO DE PANCREATITIS AGUDA

N1052 (Mon Aug 03): LA REANIMACIÓN CON CRISTALOIDES ES UNA MEDIDA FUNDAMENTAL DURANTE LAS PRIMERAS HORAS DE LA PANCREATITIS AGUDA

N1053 (Mon Aug 03): LA SOLUCIÓN DE RINGER LACTATO ES EL CRISTALOIDE PREFERIDO PARA LA REANIMACIÓN INICIAL EN PANCREATITIS AGUDA

N1061 (Thu Aug 06): LA PANCREATITIS CRÓNICA ES UN PROCESO INFLAMATORIO PERSISTENTE E IRREVERSIBLE QUE PRODUCE CAMBIOS MORFOLÓGICOS Y FUNCIONALES DEL PÁNCREAS

N1062 (Thu Aug 06): LA PRINCIPAL CAUSA DE PANCREATITIS CRÓNICA ES EL ALCOHOLISMO

N1063 (Thu Aug 06): LA TRÍADA CLÁSICA DE PANCREATITIS CRÓNICA ES CALCIFICACIONES PANCREÁTICAS, ESTEATORREA Y DIABETES

N1064 (Thu Aug 06): SE REQUIERE APROXIMADAMENTE 90% DE PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN EXOCRINA PARA QUE APAREZCAN DATOS DE MALABSORCIÓN

N1065 (Thu Aug 06): EL DIAGNÓSTICO INICIAL DE PANCREATITIS CRÓNICA SE REALIZA CON ULTRASONIDO O TOMOGRAFÍA

N1066 (Fri Aug 07): EL ESTÁNDAR DE ORO PARA EL DIAGNÓSTICO DE PANCREATITIS CRÓNICA ES LA CPRE

N1067 (Fri Aug 07): EN LA PANCREATITIS CRÓNICA LAS CONCENTRACIONES DE AMILASA Y LIPASA PUEDEN SER NORMALES

N1068 (Fri Aug 07): EL TRATAMIENTO DE LA PANCREATITIS CRÓNICA AUTOINMUNE ES CON CORTICOESTEROIDES

N1072 (Mon Aug 10): LA LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA PURA PERMITE CONFIRMAR O DESCARTAR UNA PATOLOGÍA SIN REALIZAR UNA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA ADICIONAL

N1073 (Mon Aug 10): LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PURA PERMITE TRATAR COMPLETAMENTE LA PATOLOGÍA IDENTIFICADA SIN CONVERSIÓN A CIRUGÍA ABIERTA

N1081 (Wed Aug 12): EL SÍNDROME DE LYNCH SE ASOCIA A MUTACIONES EN GENES REPARADORES DEL ADN Y AUMENTA EL RIESGO DE CÁNCER COLORRECTAL Y ENDOMETRIAL

N1082 (Wed Aug 12): EN EL SÍNDROME DE LYNCH SE RECOMIENDA COLONOSCOPIA CADA 1 A 2 AÑOS A PARTIR DE LOS 18 AÑOS

N1083 (Wed Aug 12): LAS PRUEBAS GENÉTICAS PARA SÍNDROME DE LYNCH SE SOLICITAN CUANDO SE CUMPLEN LOS CRITERIOS CLÍNICOS DE ÁMSTERDAM

N1090 (Thu Aug 13): EL SÍNDROME ANTICOLINÉRGICO SE CARACTERIZA POR TAQUICARDIA, MIDRIASIS, HIPERTERMIA, PIEL SECA, RUBICUNDEZ Y RETENCIÓN URINARIA

N1091 (Fri Aug 14): EL ANTÍDOTO ESPECÍFICO DEL SÍNDROME ANTICOLINÉRGICO ES LA FISOSTIGMINA

N1092 (Fri Aug 14): LA COCAÍNA Y LAS ANFETAMINAS PUEDEN PRODUCIR UN TOXÍNDROME SIMPATICOMIMÉTICO

N1093 (Fri Aug 14): EL TOXÍNDROME SIMPATICOMIMÉTICO SE CARACTERIZA POR TAQUICARDIA, HIPERTENSIÓN, AGITACIÓN, DIAFORESIS, MIDRIASIS Y AGRESIVIDAD

N1094 (Fri Aug 14): LAS BENZODIACEPINAS SON EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO INDICADO EN EL TOXÍNDROME SIMPATICOMIMÉTICO

N1098 (Wed Aug 19): LA ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA POR TROMBOSIS VENOSA PUEDE PRESENTARSE CON DOLOR ABDOMINAL SORDO, DIARREA Y EVACUACIONES CON SANGRE

N1099 (Wed Aug 19): LA ANGIOGRAFÍA ES EL ESTÁNDAR DE ORO SEÑALADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA

N1100 (Wed Aug 19): LA COLITIS ISQUÉMICA AFECTA CON MAYOR FRECUENCIA EL COLON IZQUIERDO, PARTICULARMENTE EL ÁNGULO ESPLÉNICO O PUNTO DE GRIFFITH

N1102 (Thu Aug 20): EL ESTUDIO INICIAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE ADENITIS MESENTÉRICA ES EL ULTRASONIDO ABDOMINAL

N1103 (Thu Aug 20): EL HALLAZGO ULTRASONOGRÁFICO DE LA ADENITIS MESENTÉRICA ES UN NÓDULO MESENTÉRICO HIPOECHOICO

N1104 (Thu Aug 20): LA TUBERCULOSIS GENITOURINARIA ES EL SEGUNDO SITIO DE INFECCIÓN EXTRAPULMONAR POR TUBERCULOSIS

N1105 (Thu Aug 20): LA TRÍADA DE COLOMBINO EN TUBERCULOSIS GENITOURINARIA CONSISTE EN ORINA ÁCIDA, PIURIA Y ORINA ASÉPTICA

N1106 (Fri Aug 21): EL CULTIVO DE LÖWENSTEIN ES EL ESTUDIO DE ELECCIÓN SEÑALADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS GENITOURINARIA

N1109 (Fri Aug 21): EL TRATAMIENTO INICIAL DE LA RETENCIÓN URINARIA ES LA CATETERIZACIÓN VESICAL CON Sonda FOLEY

N1110 (Fri Aug 21): EL VARICOCELE ES LA PRINCIPAL CAUSA DE INFERTILIDAD MASCULINA EN EL MUNDO

N1115 (Fri Aug 21): EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE PRIMERA ELECCIÓN DEL ESPASMO ESOFÁGICO DIFUSO CONSISTE EN BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO O NITRATOS SUBLINGUALES

N1117 (Fri Aug 21): EL ESTÁNDAR DE ORO PARA EL DIAGNÓSTICO DE ERGE ES LA PHMETRÍA CON IMPEDANCIA DE 24 HORAS

N1118 (Fri Aug 21): LA FUNDUPPLICATURA DE NISSEN ES EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ELECCIÓN PARA LA ERGE

N1132 (Fri Aug 28): LA MNEMOTECNIA AMPLE SIGNIFICA ALERGIAS, MEDICAMENTOS, PATOLOGÍAS O EMBARAZO, LIBACIONES Y EVENTOS